



Malang, 23 April 2026

Nomor : 755/E-PM/DIR/IV/2026
Lampiran : 33 Halaman
Perihal : Surat Permohonan *Benchmarking* Data Mutu dan Surveilans Infeksi (HAI's)

Kepada Yth

Ns. Heni Indra Wulansari, M. Kep
Direktur RS Prima Husada Sukorejo
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses akreditasi Rumah Sakit yang mana dicantumkan perlunya dilakukan *benchmarking*/perbandingan data mutu dan surveilans infeksi (HAI's) dengan rumah sakit lain, maka dengan ini saya:

Nama : dr. Resti Lestantini, M. Kes
Jabatan : Direktur
Rumah Sakit : Prima Husada Malang
Alamat : Banjararum Selatan No 3 – 7 Singosari, Malang
Telp/email : 0341 – 458679, 458916 / sekretariat@malang.rs-primahusada.com

Mengajukan permohonan untuk melakukan pertukaran data mutu dan surveilans HAI's pada bulan Januari – Juni 2025 (Semester I) dan Juli – Desember 2025 (Semester II) di Rumah Sakit yang Ibu pimpin.

Permohonan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk dapat diproses lebih lanjut.. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Resti Lestantini, M. Kes

HASIL CAPAIAN INDIKATOR NASIONAL MUTU
RS PRIMA HUSADA MALANG

Tabel Data Hasil Capaian Indikator Nasional Mutu RS Prima Husada Malang Periode Januari – Juni 2025

No	Indikator	STAND	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN		
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥85%	85,21%	85,35%	85,32%	85,36%	85,49%	85,21%	85,32%	Tercapai
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (apd)	100%	93,01%	93,06%	93,1%	93,22%	93,54%	96,3%	93,71%	Tidak Tercapai
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	99,55%	99,92%	99,77%	99,96%	99,88%	100%	99,85%	Tidak Tercapai
4	Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
5	Waktu tunggu rawat jalan	≥80%	89,16%	89,38%	99,1%	98,21%	97,58%	97,33%	95,13%	Tercapai
6	Penundaan operasi elektif	≤5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Tercapai
7	Kepatuhan waktu <i>visite</i> dokter	≥80%	75,9%	76,21%	74,93%	74,19%	72,26%	78,28%	75,30%	Tidak Tercapai
8	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	96,9%	97,31%	100%	100%	100%	100%	99,04%	Tidak Tercapai
9	Kepatuhan penggunaan formularium nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

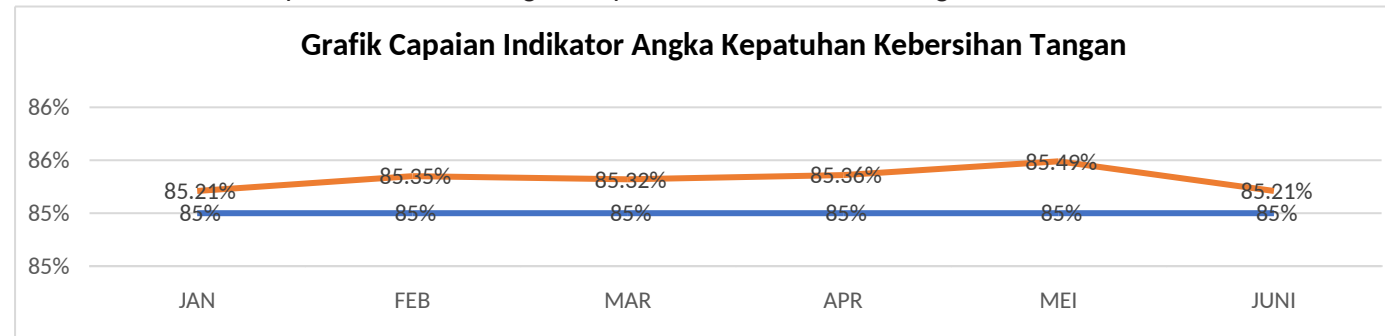


	(clinical pathway)									
11	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	99,75%	98,64%	99,1%	99,44%	97,65%	99,09%	98,95%	Tidak Tercapai
12	Kecepatan waktu tanggap komplain	≥80%	100%	99,92%	100%	100%	100%	100%	99,99%	Tercapai
13	Kepuasan pasien	≥76.61%	99,81%	99,79%	100%	99,88%	99,76%	97,12%	99,39%	Tercapai

Analisis Hasil Capaian Indikator Nasional Mutu RS Prima Husada Malang Periode Januari – Juni 2025

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Gambar 1. Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35%, capian di bulan Maret yaitu 85,32%, capaian di bulan April yaitu 85,36%, capaian di bulan Mei 85,49% dan capaian di bulan Juni adalah 85,21 dengan rata rata bulan Januari hingga Juni yaitu 85,32%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.

PLAN

Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin hingga 100%.



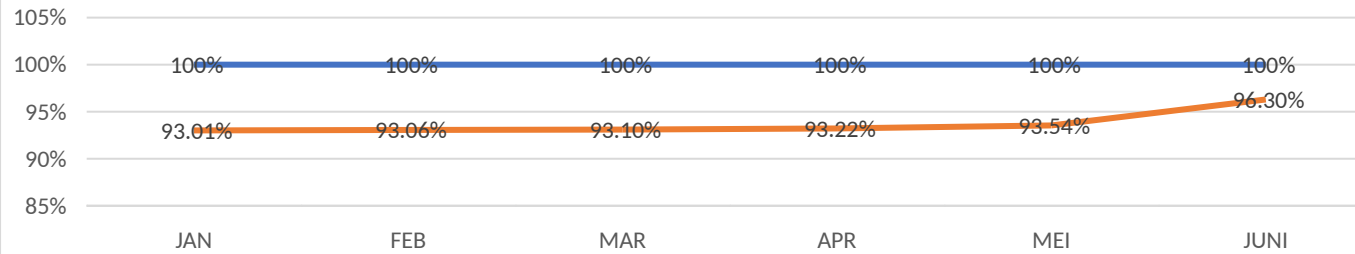
DO	- Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. - Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. - Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. - Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. - Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.				
STUDY	Dari grafik indikator angka kepatuhan kebersihan tangan bulan Januari tahun 2025 diketahui bahwa capaian telah mencapai standart yaitu 85,21% dan pada bulan Februari capaian meningkat menjadi 85,35%, capaian di bulan Maret yaitu 85,32%, capaian di bulan April yaitu 85,36%, capaian di bulan Mei 85,49% dan capaian di bulan Juni adalah 85,21 dengan rata rata bulan Januari hingga Juni yaitu 85,32%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kebersihan tangan.	- Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	- Seluruh petugas pelayanan pasien	- Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. - Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. - Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. - Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. - Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	- Satu bulan

2. Kepatuhan Penggunaan APD

Gambar 2 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pada bulan Januari hingga Juni Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

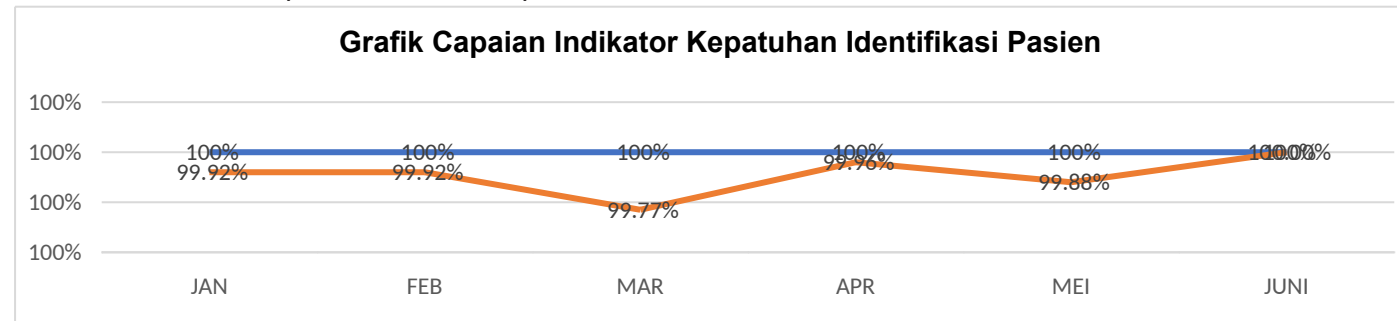
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin hingga 100%.				
DO	- Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. - Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. - Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. - Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD petugas dapur). - Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter. - Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.				
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart. Capaian di bulan Januari tahun 2025 yaitu 93,01%, bulan Februari sebesar 93,06%, bulan Maret sebesar 93,1%, bulan April 93,22%, bulan Mei 93,54% dan bulan Juni 96,3% dengan rata-rata 93,7%. Dari hasil monitoring dan supervise, masih ditemukan petugas perawat yang memakai APD tidak sesuai dengan jenis tindakan dan transmisi penyakit, misalnya seperti injeksi lewat selang infus / hanya TTV ke pasien non infeksi namun menggunakan handscoon. Kepatuhan APD petugas dapur terutama pengolah makanan masih sangat kurang terutama penggunaan masker. Untuk petugas medis, masih ditemukan DPJP yang masih menggunakan handscoon meskipun hanya visite tidak melakukan tindakan. Untuk petugas CS ditemukan masih menggunakan handscon medis untuk mengepel yang seharusnya menggunakan handscoon kerja.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	- Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	- Tercapainya kepatuhan APD hingga maksimal 100%.	- Berkolaborasi dengan IPCD untuk melakukan edukasi terhadap para DPJP. - Monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai di lapangan. - Lakukan supervise terkait ketersediaan dan	- Seluruh petugas yang melakukan pelayanan	- Satu Bulan



			kesesuaian penggunaan APD. - Berikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. - Berikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. - Tanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.	di RS.	
--	--	--	--	--------	--

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Gambar 3. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari hingga Mei Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, pada bulan Juli tahun 2025 capaian telah meningkat menjadi 100%.

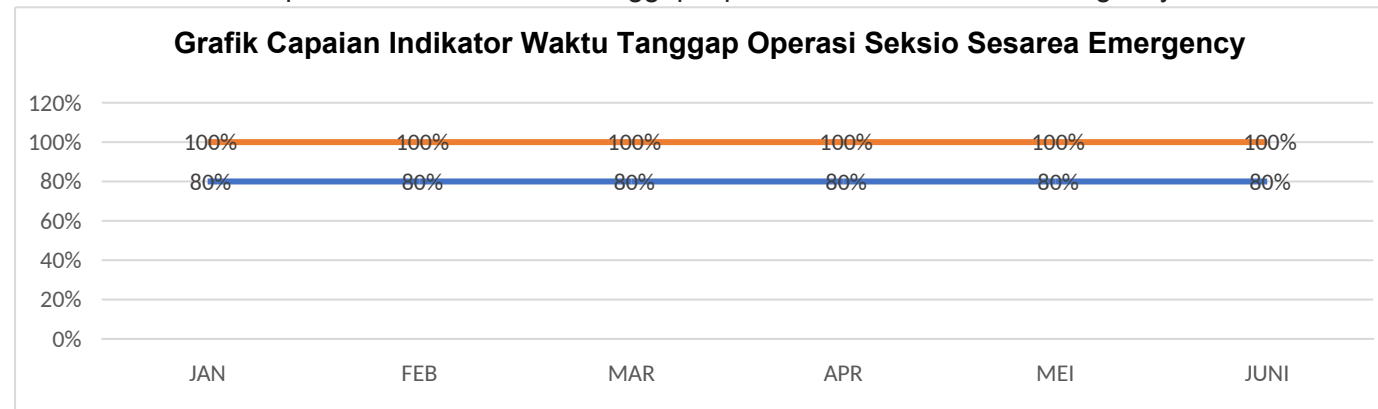
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).				
DO	- Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan - Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien - Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat diketahui bahwa capaian kepatuhan identifikasi pasien di RS Prima Husada Malang masih belum mencapai standart dengan capaian bulan Januari tahun 2025 yaitu 99,92 %, bulan Februari sebesar 99,92%, bulan Maret sebesar 99,77% capaian di bulan April yaitu 99,96%, capaian di bulan Mei 99,88% dan capaian di bulan Juni adalah 100% dengan rata rata 99,85%. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Mempertahank	- Mempertahankan	- Tercapainya	- Terus melakukan supervisi pada petugas unit	- Seluruh	- Satu Bulan



an kepatuhan identifikasi pasien	kepatuhan identifikasi pasien	indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	- Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat.	petugas yang melakukan pelayanan di RS.	
----------------------------------	-------------------------------	--	--	---	--

4. Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

Gambar 4. Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency



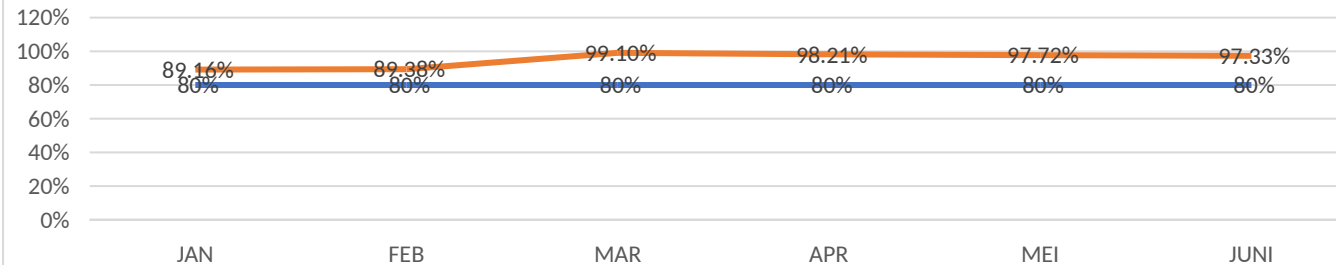
Dari grafik indikator waktu tanggap SC emergency bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian waktu SC emergency. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

5. Waktu Tunggu Rawat Jalan

Gambar 5. Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



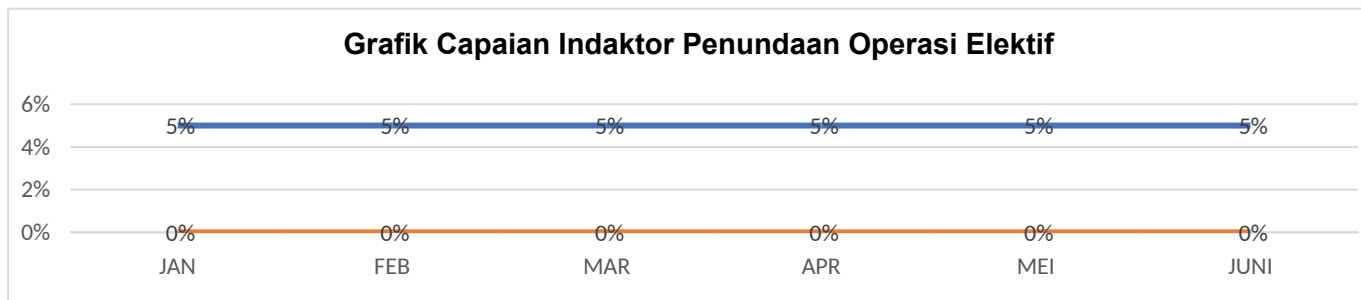
Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



Berdasarkan grafik capaian indikator waktu tunggu rawat jalan pada bulan Januari Tahun 2025 capaian telah mencapai standart dengan capaian 98,16%, capaian di bulan Februari 89,38%, capaian di bulan Maret 99,1%, capaian di bulan April 98,22%, capaian di bulan Mei 97,71% dan capaian di bulan Juni adalah 97,33% dengan rata-rata 93,13%. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara manajemen dan juga DPJP yang sudah berusaha datang tepat waktu dan evaluasi berkelanjutan yang telah dilakukan manajemen terhadap keterlambatan DPJP. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

6. Penundaan Operasi Elektif

Gambar 6. Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif



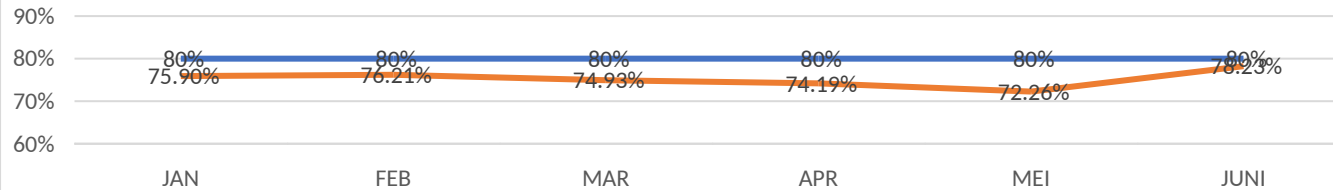
Dari grafik indikator penundaan operasi elektif bulan Januari hingga Juni tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 0%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator penundaan operasi elektif. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

7. Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Gambar 7. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter



Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite Dokter pada bulan Januari hingga Juni Tahun 2025 belum mencapai standart, hal ini disebabkan karena Seluruh dokter Klinisi di Rumah Sakit Prima Husada adalah dokter tamu dari luar, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

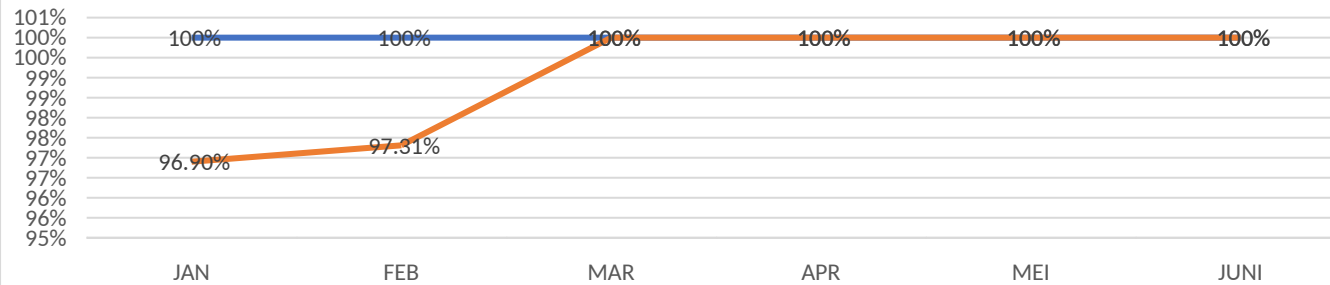
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan masukan pada SDM dan Kabid pelayanan untuk melakukan rekrutmen home dokter lebih banyak				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 75,9%, capaian di bulan februari yaitu 76,21%, capaian di bulan Maret yaitu 74,93%, capaian di bulan April yaitu 74,19%, capaian di bulan Mei yaitu 72,26% dan capaian di bulan Juni yaitu 78,23% dengan rata-rata 75,3%. Dari hasil supervisi didapatkan Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena masih banyak dokter yang visite diatas jam 14.00 karena masih bertugas di RS asal karena RS Prima Husada belum memiliki dokter tetap. Dokter visite jam 07.00-14.00 : dr. Ira, Sp.JP, dr. Mira, Sp.JP, dr. Anton, Sp.B, dr. dr. Dicky,Sp.A , dr. Elvi, Sp.P, dr. Dewi, Sp.S, dr. Ardhi, Sp.PD, dr. Humairoh, Sp.Og, dr. Aida, Sp.Og, dr. Nimim, Sp.THT.KL, dr. dr. Aji, Sp.PD. Dokter visite jam 14.00-21.00 : dr. Heriyatmo, Sp.PD, dr. Andi, Sp.P, dr. Farid, Sp.S, dr. Yoga, Sp.JP (Tidak menentu), dr. Ardani, Sp.DP (tidak menentu)				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	- Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	- Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan selanjutnya	Melakukan KIE dan komunikasi dengan DPJP terkait waktu visite dokter, hal ini menjadi PR yang cukup besar bagi tim mutu dan manajemen karena sebagian besar DPJP tidak hanya bertugas di RS Prima Husada.	Manajemen RS	- Satu Tahun

8. Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

Gambar 8. Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium



Grafik Capaian indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium



Berdasarkan grafik capaian indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium pada bulan Januari dan Februari Tahun 2025 diketahui capaian belum mencapai standart dan capaian meningkat hingga 100% di bulan Maret hingga Mei. Capaian meningkat pada bulan Maret hingga Juni yang telah mencapai standart 100%.

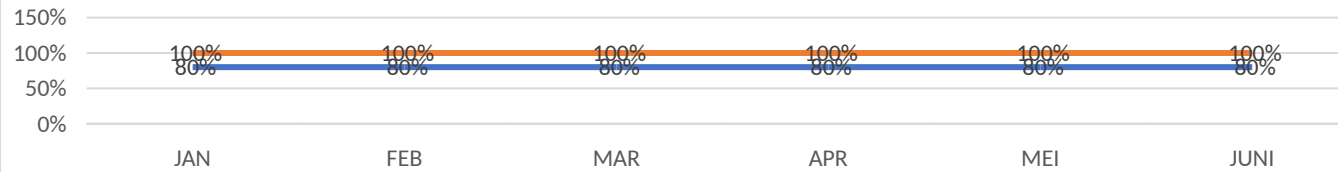
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan pelaporan hasil kritis laboratorium hingga mencapai standart 100%				
DO	Meningkatkan supervisi baik dari komite mutu maupun kepala instalasi laboratorium supaya seluruh petugas laboratorium segera melaporkan hasil kritis dan melakukan dokumentasi dengan baik dan lengkap.				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui indikator pelaporan hasil kritis laboratorium pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 96,9% dan bulan Februari 97,31%. Capaian meningkat pada bulan Maret hingga Juni yang telah mencapai standart 100%. Berdasarkan hasil supervisi masih ada petugas yang melaporkan hasil kritis laboratorium tetapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan lengkap.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	- Meningkatkan capaian indikator pelaporan hasil kritis laboratorium	- Capaian pelaporan hasil kritis laboratorium dapat mencapai standart 100% pada bulan berikutnya	- Menganalisa jumlah hasil kritis laboratorium yang terlapor dan tidak terlapor - Memasukkan catatan ketidak patuhan staf kedalam evaluasi kinerja staf secara langsung kepada petugas laboratorium yang tidak melaporkan hasil kritis laboratorium ataupun yang melapor tapi tidak dilakukan pendokumentasian dengan baik dan lengkap.	- Komite mutu - Kepala instalasi laboratorium	- Satu Tahun

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Gambar 9. Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

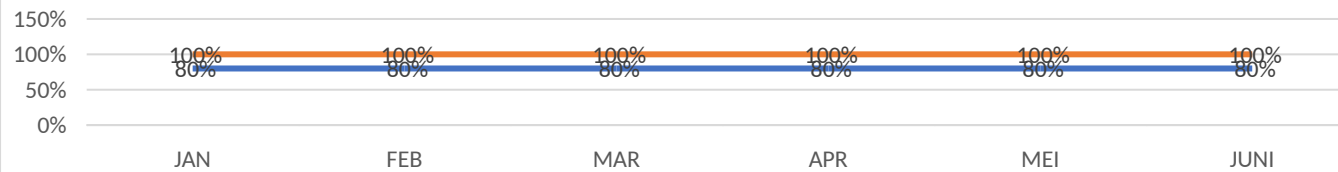


Dari grafik indikator Formularium Nasional bulan Januari hingga Mei tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2025.

10. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

Gambar 10. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis

Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



Dari grafik indikator kepatuhan terhadap alur klinis bulan Januari hingga Mei tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

Daftar Clinical Pathway Bulan Juni 2025

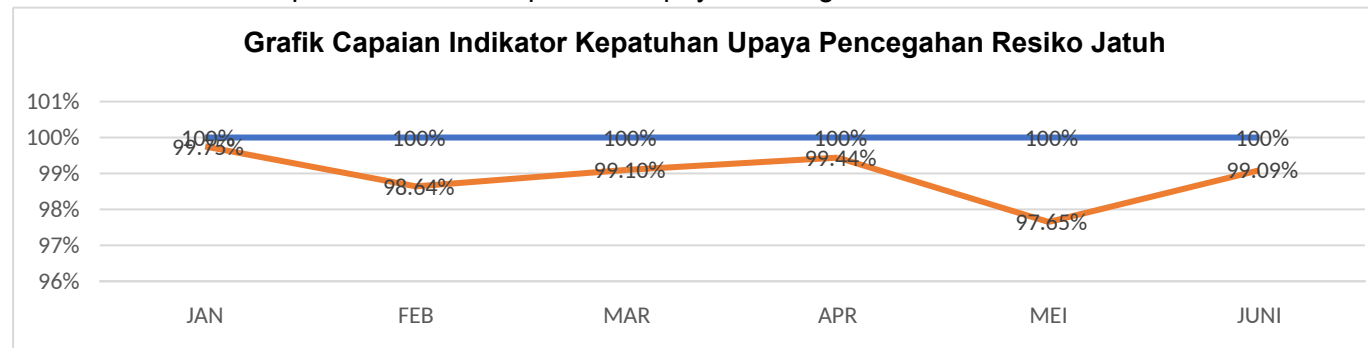
Diagnosa	Jumlah	Patuh	Tidak Patuh
DF			
CVA Infark			
Gastritis			
Batu Ureter			



DM			
GEA			
CHF			
FAM			
TB Paru			
HT			
CA Mammae			
HIV			
STEMI			
NSTEMI/UAP			
Pneumonia			
Sectio Caesarea	32		
Partus Normal	41		
Jumlah	73	73	

11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh

Gambar 11 Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari hingga Juni Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

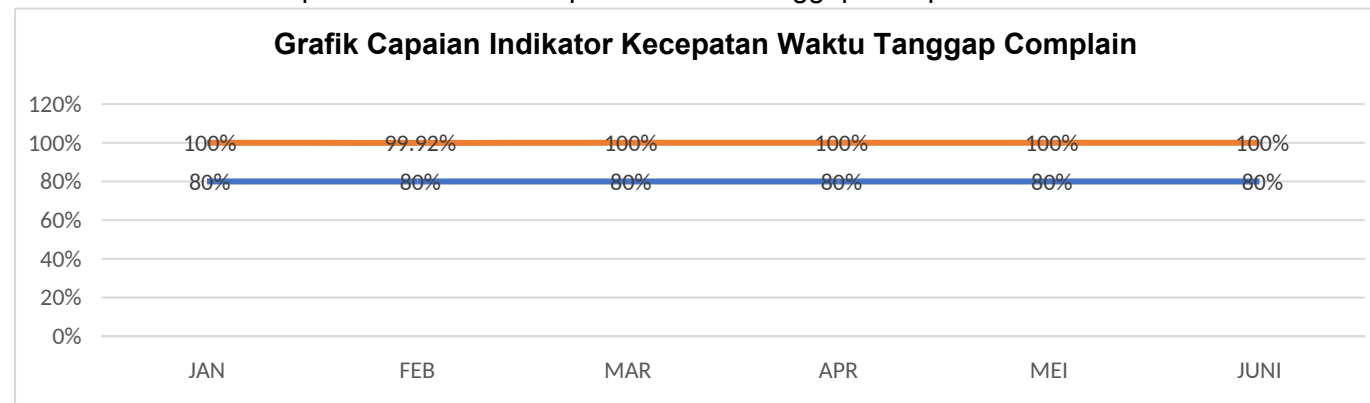
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%
------	---



DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh				
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian yaitu 99,75%, capaian di bulan Februari yaitu 98,64%, capaian di bulan Maret yaitu 99,1%, capaian di bulan April yaitu 99,44%, capaian di bulan Mei yaitu 97.65% dan capaian di bulan Juni adalah 99,09% dengan rata-rata 98,95%. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalu memasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	- Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	Melakukan supervisi berjenjang mulai dari PJ shift, kepala ruangan, kepala bidang keperawatan dan tim mutu guna memastikan perawat ruangan telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan.	Perawat instalasi rawat inap	- Satu Bulan

12. Kecepatan Waktu Tanggap Komplain

Gambar 12. Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Complain

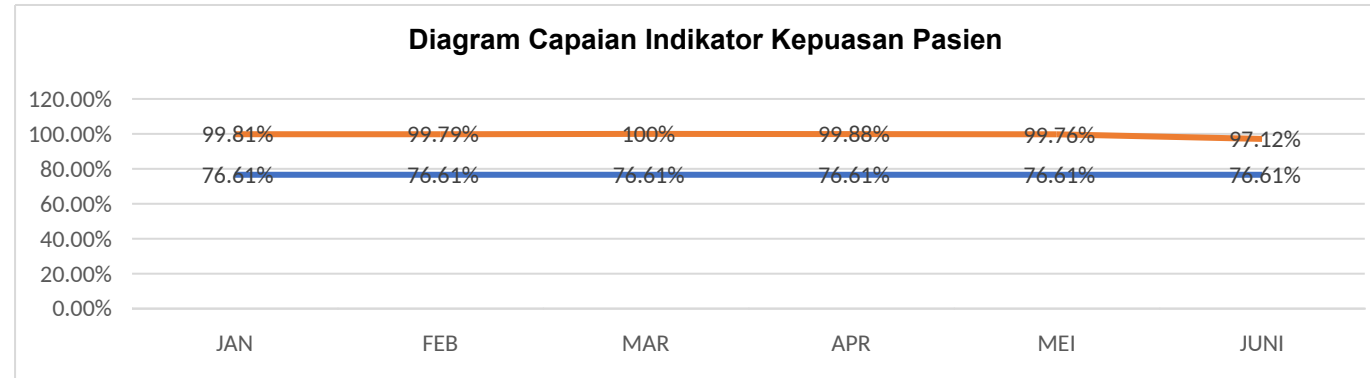




Dari grafik indikator waktu tanggap kompalian bulan Januari hingga Juni tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 80% dengan rata-rata 99,99%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara PIPP dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk segera menanggapi dan melakukan tindak lanjut terkait komplain yang diterima. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

13. Kepuasan Pasien

Gambar 13. Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Dari grafik indikator kepuasan pasien bulan Januari hingga April tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 76,61% dengan rata-rata 99.39%, meskipun belum mencapai nilai sempurna 100% tetapi capaian ini telah melebihi standart. Hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh karyawan Rumah Sakit Prima Husada Malang dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian kepuasan pasien . Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya.

Tabel Data Hasil Capaian Indikator Nasional Mutu RS Prima Husada Malang Periode Juli – Desember 2025

No	Indikator	STAND	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
1	Kepatuhan kebersihan tangan	≥85%	85,25%	85,38%	85,58%	85,32%	85,57%	85,61%	85,45%	Tercapai
2	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (apd)	100%	93,79%	94,3%	94,33%	94,52%	96,88%	96,3%	95,02%	Tidak Tercapai
3	Kepatuhan identifikasi pasien	100%	93,93%	99,94%	99,83%	99,96%	100%	100%	98,94%	Tidak Tercapai



4	Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
5	Waktu tunggu rawat jalan	≥80%	96,23%	96,60%	96,62%	96,88%	96,89%	97,33%	96,76%	Tercapai
6	Penundaan operasi elektif	≤5%	0%	0%	0,32%	0%	0%	0%	0,05%	Tercapai
7	Kepatuhan waktu <i>visite</i> dokter	≥80%	66,22%	60,55%	70,4%	62,74%	71,55%	78,28%	68,29%	Tidak Tercapai
8	Pelaporan hasil kritis laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
9	Kepatuhan penggunaan formularium nasional	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>clinical pathway</i>)	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
11	Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh	100%	96,33%	95,04%	93,45%	89,47%	96,68%	99,09%	95,01%	Tidak Tercapai
12	Kecepatan waktu tanggap komplain	≥80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
13	Kepuasan pasien	≥76.61%	99,46%	99,56%	99,89%	99,9%	99,62%	97,12%	99,26%	Tercapai

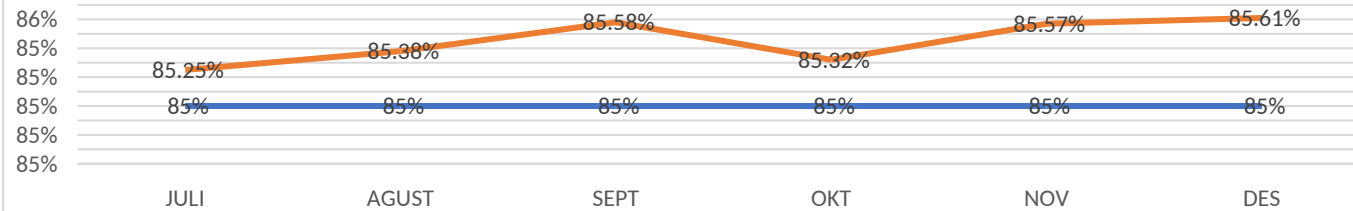
Analisis Hasil Capaian Indikator Nasional Mutu RS Prima Husada Malang Periode Juli – Desember 2025

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan

Gambar 1. Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



Grafik Capaian Indikator Angka Kepatuhan Kebersihan Tangan



Dari grafik indikator angka kepatuhan kebersihan tangan bulan Juli adalah 85,25%, Agustus sebesar 85,38%, September sebesar 85,58, Oktober 85,32%, November 85,57% dan Desember 85,61% dengan rata rata bulan Januari hingga Desember yaitu 85,39%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.

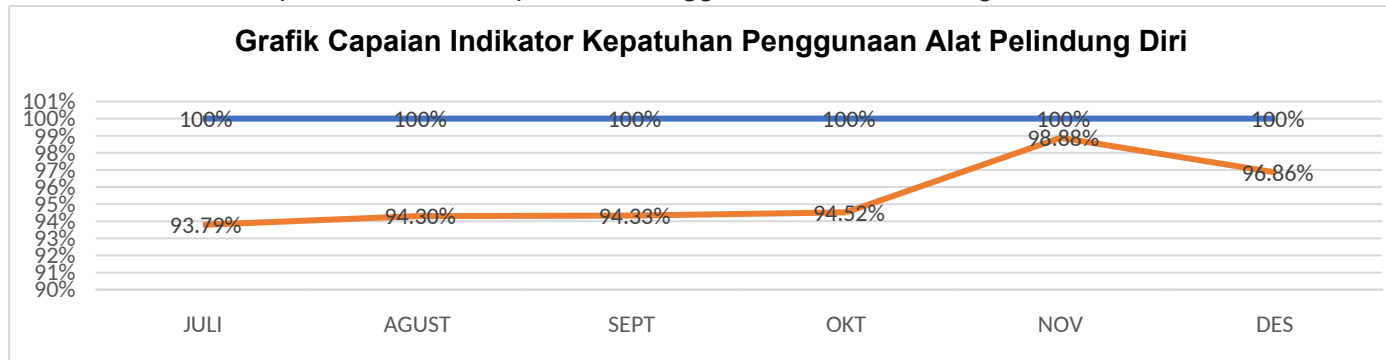
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan kebersihan tangan semaksimal mungkin hingga 100%.				
DO	- Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. - Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. - Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. - Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan tangan di unit pelayanan. - Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik.				
STUDY	Dari grafik indikator angka keptuhan kebersihan tangan bulan Juli adalah 85,25%, Agustus sebesar 85,38%, September sebesar 85,58, Oktober 85,32%, November 85,57% dan Desember 85,61% dengan rata rata bulan Januari hingga Desember yaitu 85,39%. Meskipun belum mencapai 100% tetapi nilai tersebut telah mencapai standart. Petugas masih dengan anggapan bahwa tangannya dalam kondisi masih bersih dan terkadang karena kondisi harus segera dilakukan tindakan pada pasien jadi lupa tidak melakukan cuci tangan karena memang belum terbiasa. Di harapkan capaian ini dapat ditingkatkan di bulan berikutnya.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kebersihan tangan.	- Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan.	- Seluruh petugas pelayanan pasien	- Lakukan audit kepatuhan kebersihan tangan secara rutin. - Anjurkan IPCLN untuk membuat video edukasi terkait cuci tangan sebagai media sosialisasi. - Berikan reward pada unit yang prosentase cuci tangannya baik. - Lakukan control monitoring fasilitas kebersihan	- Perawat /Bidan - Dokter - Karu - IPCLN/IPCN	- Satu bulan



- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | tangan di unit pelayanan.
- Berikan proses pembelajaran pada petugas yang belum paham atau tidak menjalankan kebersihan tangan dengan baik. | | |
|--|--|--|--|--|--|

2. Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Gambar 2. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pada bulan Januari hingga Desember Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

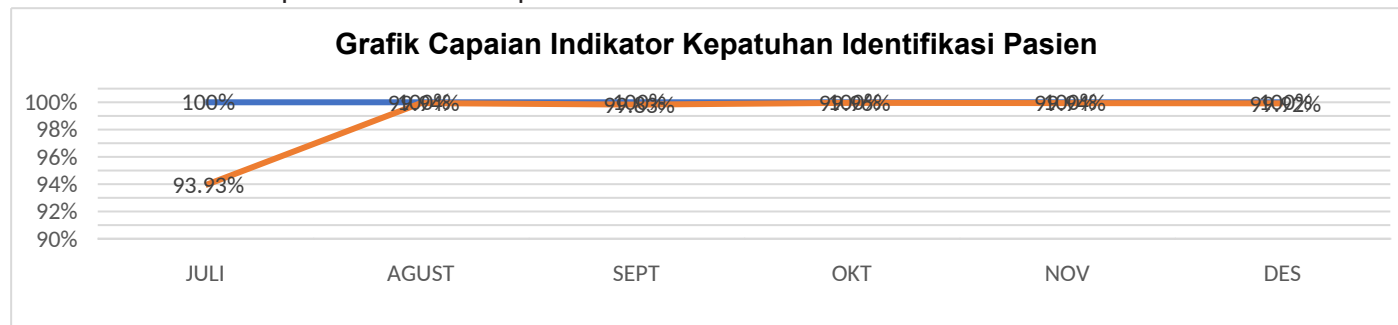
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan penggunaan APD semaksimal mungkin hingga 100%.
DO	- Melakukan monitoring pelaksanaan audit kepatuhan penggunaan APD yang sesuai. - Melakukan supervise terkait ketersediaan dan kesesuaian penggunaan APD. - Memberikan edukasi pemakaian APD yang tepat antar staf dibantu oleh IPCLN dan anggota Komite PPI lainnya. - Memberikan proses pembelajaran kepala unit dan IPCLN yang anggotanya ketahuan tidak patuh dalam pemakaian APD. (mendata ketidakpatuhan pemakaian APD petugas dapur). - Sudah dikeluarkan edaran terkait penggunaan jas dokter. - Menanamkan kesadaran pada pribadi masing-masing petugas bahwa pemakaian APD yang benar ini penting.
STUDY	Prosentase kepatuhan penggunaan APD keseluruhan belum mencapai standart. Capaian di bulan Januari tahun 2025 yaitu 93,01%, bulan Februari sebesar 93,06%, bulan Maret sebesar 93,1%, bulan April 93,22%, bulan Mei 93,54%, bulan Juni 96,3% dan bulan Juli 93,79% serta bulan Agustus sebesar 94,3%, bulan September yaitu 94,33%, bulan Oktober 94,2%, bulan November 96,88% dan Desember 96,86% dengan rata-rata 94,41%. Ketidakpatuhan ini berpotensi meningkatkan risiko penularan infeksi silang antar pasien dan tenaga kesehatan. Berdasarkan temuan, masih ada petugas yang dengan sengaja tetap menggunakan handscoon untuk menulis rekam medis. Selain itu masih ada DPJP yang menggunakan satu APD untuk visit ke seluruh pasien. Hal tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran dan disiplin dalam



penggunaan APD.					
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD.	- Meningkatkan kepatuhan pemakaian APD di unit.	- Tercapainya kepatuhan APD hingga maksimal 100%.	- Sosialisai secara berkelanjutan tentang pentingnya penggunaan APD kepada seluruh tenaga Kesehatan - Melakukan audit harian kepatuhan APD dan memberikan Feedback langsung - Memberikan apresiasi (reward) bagi tenaga Kesehatan yang patuh	- Kepala ruangan dan IPCN - Kepala ruangan - Kepala Bidang	- Satu Bulan

3. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Gambar 3. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Identifikasi Pasien



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Juli yaitu 93,93%, bulan Agustus yaitu 99,94%, bulan September yaitu 99,83%, bulan Oktober yaitu 99,96%, bulan November 99,94% dan Desember 99,92% dengan rata rata bulan Januari hingga Desember 99,38%.

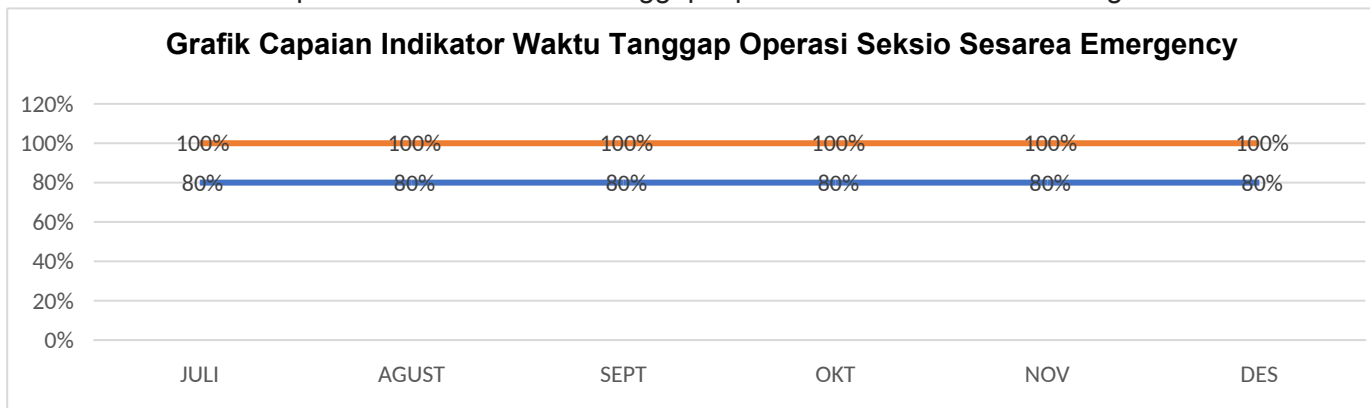
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan identifikasi pasien semaksimal mungkin (100%).
DO	- Melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkelanjutan - Kepala Instalasi untuk terus melaksanakan supervisi dan sosialisasi terkait identifikasi pasien - Memberikan teguran kepada petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien atau melakukan identifikasi tetapi masih salah
STUDY	Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan Januari hingga Mei Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, pada bulan Juni tahun 2025 capaian telah meningkat menjadi 100%,namun kembali menurun di bulan Juli yaitu 93,93%, bulan Agustus yaitu 99,94%, bulan September yaitu 99,83%, bulan Oktober yaitu 99,96%, bulan November 99,94% dan Desember 99,92% dengan



	rata rata bulan Januari hingga Desember 99,38%. Dari temuan dilapangan diketahui bahwa DPJP seringkali tidak melakukan identifikasi pasien ketika melakukan visite karena sudah didampingi oleh perawat. Supervisi secara berkelanjutan serta memberikan teguran secara langsung cukup efektif untuk meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien.				
ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	- Mempertahankan kepatuhan identifikasi pasien	- Tercapainya indikator kepatuhan identifikasi pasien pada bulan berikutnya.	- Terus melakukan supervisi pada petugas unit - Memberikan teguran secara langsung jika menemukan petugas yang tidak melakukan identifikasi pasien dengan tepat. - Perawat diharapkan bisa membantu melakuakn identiifikasi pasien ulang ketika melakukan visite	- Seluruh petugas yang melakukan pelayanan di RS.	- Satu Bulan

4. Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergency

Gambar 4. Grafik Capaian Indikator Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi

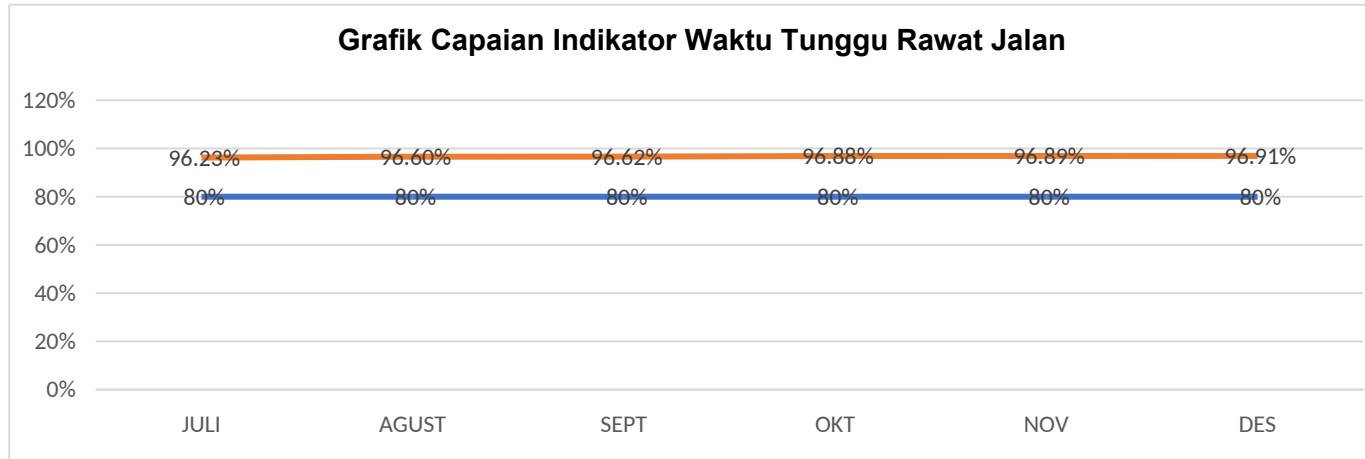


Dari grafik indikator waktu tanggap SC emergency bulan Juli hingga bulan Desember tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Gawat Darurat, Unit Maternitas dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk mempertahankan capaian waktu SC emergency. Ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana yang mendukung juga menjadi faktor tercapainya indikator waktu tanggap operasi SC emergency. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun berikutnya.



5. Waktu Tunggu Rawat Jalan

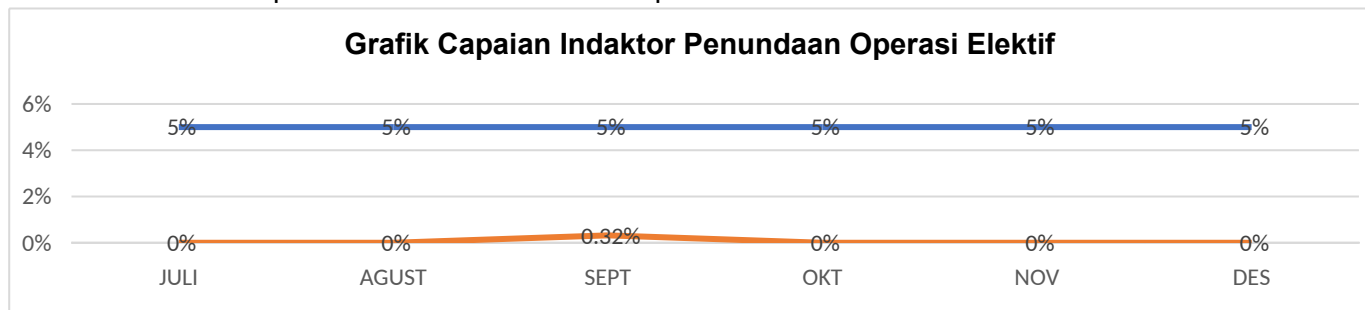
Gambar 5. Grafik Capaian Indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan



Berdasarkan grafik capaian indikator waktu tunggu rawat jalan pada bulan Juli adalah 96,23%, capaian di bulan Agustus yaitu 96,60%, di bulan September yaitu 96,52%, capaian di bulan Oktober yaitu 96,88%, capaian di bulan November yaitu 96,89% dan Desember 96,91% dengan rata-rata 95,91%. Hal ini berkat kerjasama yang baik antara manajemen dan juga DPJP yang sudah berusaha datang tepat waktu dan evaluasi berkelanjutan yang telah dilakukan manajemen terhadap keterlambatan DPJP. Adanya aturan baru bahwa pasien bisa di daftar 1 jam sebelum jadwal praktek dokter juga sangat membuat waktu tunggu rawat jalan menjadi lebih pendek. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2026 dengan cara Optimalisasi alur pendaftaran dan koordinasi antar unit.

6. Penundaan Operasi Elektif

Gambar 6. Grafik capaian Indikator Penundaan Operasi Elektif



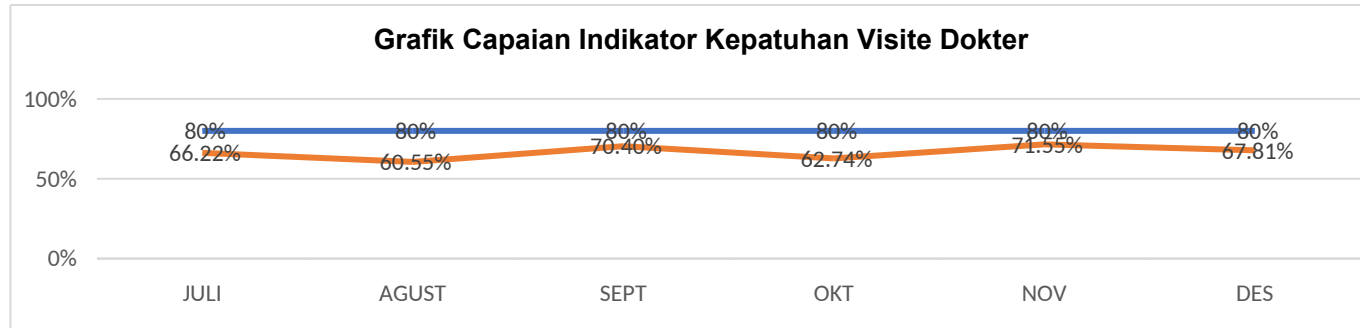
Dari grafik indikator penundaan operasi elektif bulan Juli hingga Desember tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart dengan rata rata 0,05% hal ini berkat kerjasama yang baik antara unit Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Kamar Operasi serta manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang



telah bersinergi untuk mempertahankan capaian indikator penundaan operasi elektif. Perencanaan yang matang dari segi SDM, alat dan ruang operasi juga telah dilakukan guna meminimalisir terjadinya penundaan operasi elektif. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2026 melalui ketersediaan alat dan kesiapan tim.

7. Kepatuhan Waktu Visite Dokter

Gambar 7. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Visite Dokter



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan visite Dokter pada bulan Januari hingga Desember Tahun 2025 belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

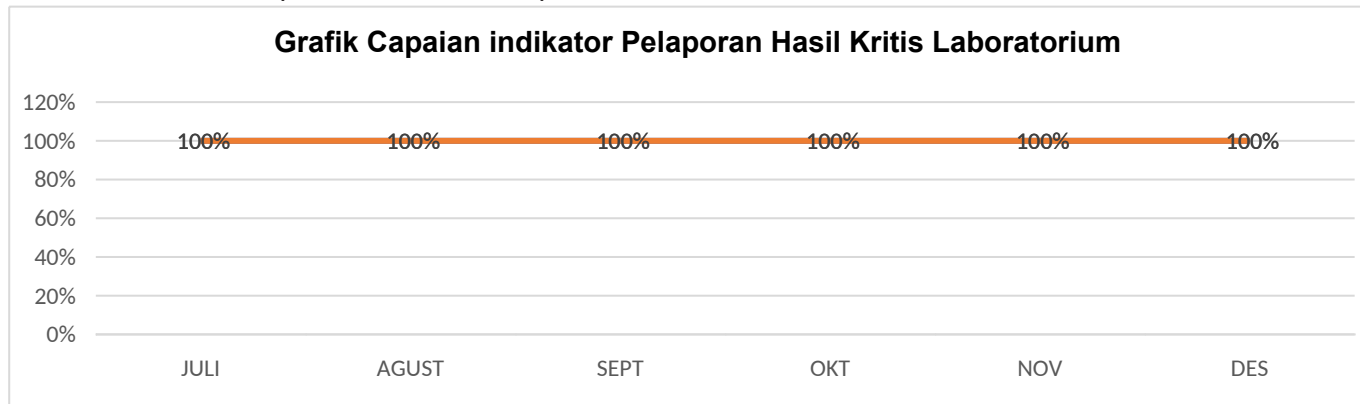
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan angka kepatuhan waktu visite dokter hingga dapat mencapai standart 80%.				
DO	Memberikan masukan pada SDM dan Kabid pelayanan untuk melakukan rekrutmen home dokter lebih banyak				
STUDY	Berdasarkan hasil capaian di atas, diketahui persentase kepatuhan waktu visite dokter pada bulan Januari tahun 2025 belum mencapai standart dengan capaian 75,9%, capaian di bulan februari yaitu 76,21%, capaian di bulan Maret yaitu 74,93%, capaian di bulan April yaitu 74,19%, capaian di bulan Mei yaitu 72,26%, capaian di bulan Juni yaitu 78,23%, capaian di bulan Juli yaitu 66,22% dan capaian di bulan Agustus yaitu 60,55%, capaian bulan September yaitu 70,4%, Oktober 62,74%, November 71,55% dan Desember 67,81% dengan rata-rata 70,92%. Dari hasil supervisi didapatkan. nnya Angka kepatuhan waktu visite Dokter belum mencapai standart karena dokter seringkali memiliki jadwal yang padat termasuk jadwal praktik klinik dan tugas di rumah sakit lain. Selain itu budaya di rumah sakit yang belum sepenuhnya mengutamakan kepatuhan terhadap indikator mutu nasional, diaman visite di anggap fleksibel atau dapat di sesuaikan di luar jam standart.				
	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	- Meningkatkan kepatuhan waktu visite dokter	- Capaian Kepatuhan Visite dokter bisa meningkat pada bulan	- Kepala ruangan memantau kehadiran dokter pada waktu visite yang dijadwalkan. - Data dikumpulkan dan dibandingkan dengan jadwal resmi. - Supervisi secara konsisten - Mengkomunikasikan dengan DPJP supaya	Manajemen RS	- Satu Bulan



		selanjutnya	berkomitmen untuk visite di jam yang sudah disepakati supaya ketika pasien bertanya, perawat bisa menjelaskan secara tepat.		
--	--	-------------	---	--	--

8. Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

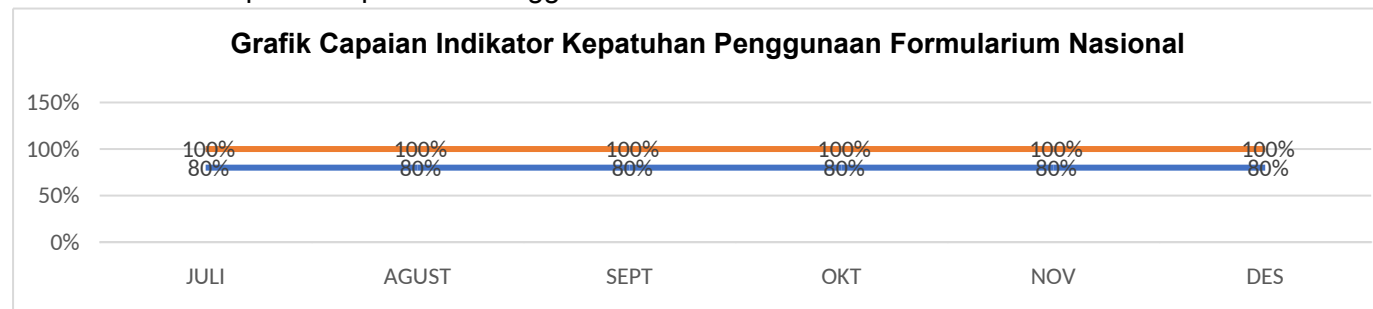
Gambar 8. Grafik Capaian Indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium



Berdasarkan grafik capaian indikator Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium pada bulan Juli sampai Desember Tahun 2025 telah mencapai standar 100%. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2026.

9. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

Gambar 9. Grafik Capaian Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional



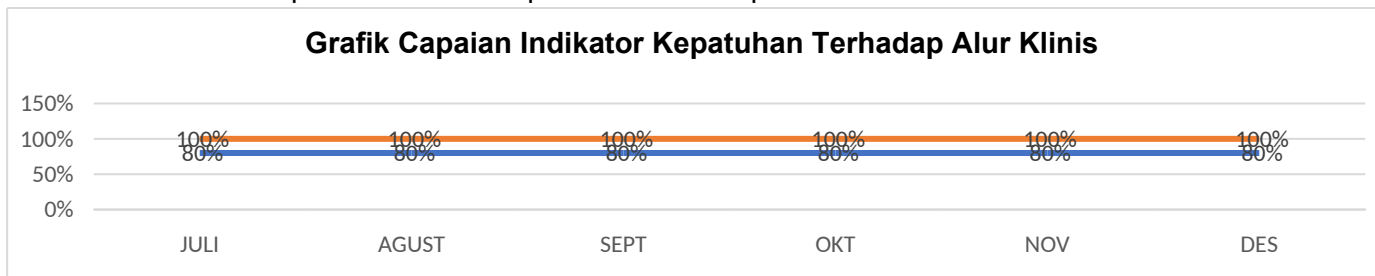
Dari grafik indikator Formularium Nasional bulan Juli hingga Desember tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart $\geq 80\%$, hal ini kerjasama yang baik antara dokter penanggungjawab pasien, instalasi farmasi dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk



mempertahankan capaian kepatuhan penggunaan formularium Nasional . Adanya payung hukum yang kuat, seperti Keputusan Menteri Kesehatan tentang Formularium Nasional, memberikan landasan hukum yang wajib dipatuhi oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan juga menjadi faktor yang membuat rumah sakit wajib mematuhi standart formularium nasional. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun 2026.

10. Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway)

Gambar 10. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Terhadap Alur Klinis



Dari grafik indikator kepatuhan terhadap alur klinis bulan Juli hingga Desember tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart 100%, unit yang patuh dalam pengisian CP daalah unit maternitas dengan diagnosa partus normal dan SC. Alur klinis sendiri sebenarnya membantu menstandardisasi perawatan untuk diagnosis tertentu, memastikan konsistensi dalam pelayanan yang diberikan kepada pasien.

Daftar Clinical Pathway Bulan Desember 2025

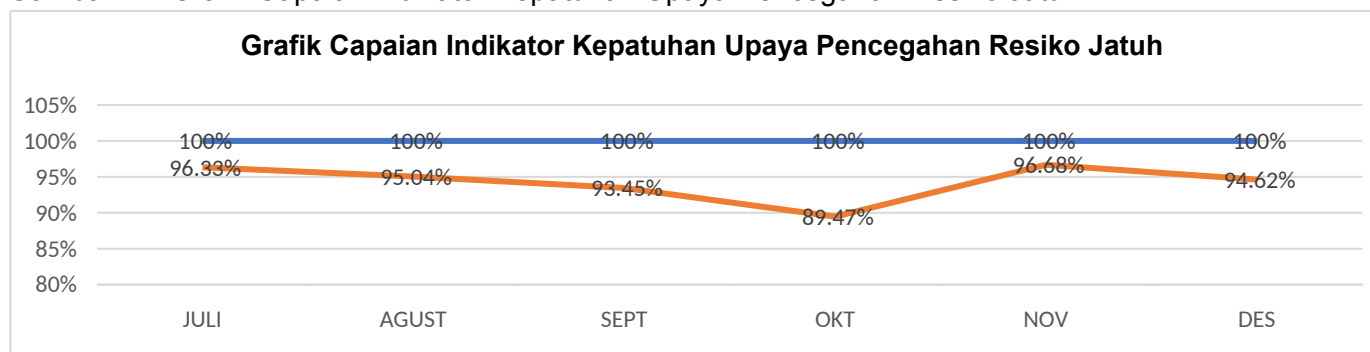
Diagnosa	Jumlah	Patuh	Tidak Patuh
DF			
CVA Infark			
Gastritis			
Batu Ureter			
DM			
GEA			
CHF			
FAM			
TB Paru			
HT			
CA Mammae			



HIV			
STEMI			
NSTEMI/UAP			
Pneumonia			
Sectio Caesarea		74	
Partus Normal		51	
Jumlah		125	

11. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh

Gambar 11. Grafik Capaian Indikator Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Jatuh



Berdasarkan grafik capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Juli hingga Desember Tahun 2025 capaian belum mencapai standart, oleh karena itu perlu dilakukan PDSA dengan langkah-langkah sebagai berikut :

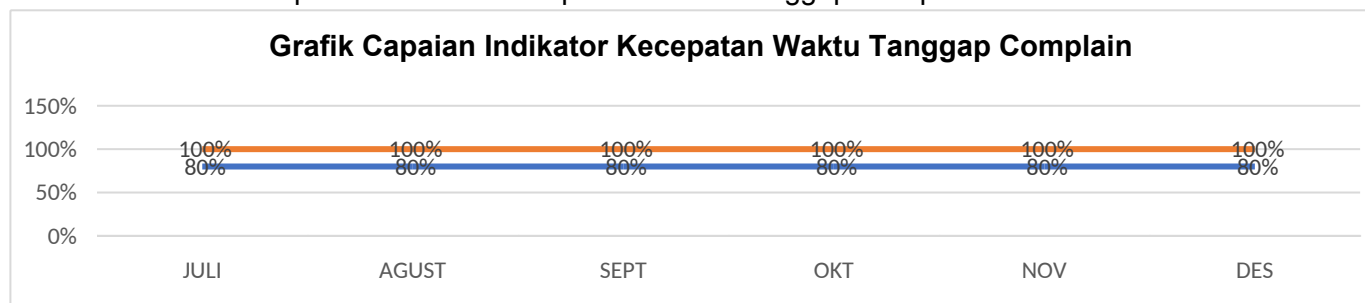
PLAN	Kami berencana untuk meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh hingga mencapai standart 100%
DO	Meningkatkan KIE kepada pasien dan keluarga tentang kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh
STUDY	Berdasarkan capaian diatas, dapat diketahui bahwa prosentase kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pada bulan Juli adalah 96,33% dan capaian di bulan Agustus yaitu 95,04%, September 93,45%, Oktober 89,47%, November 96,68% dan Desember 94,62% dengan rata-rata 96,61%. Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh belum mencapai standart karena masih ditemukan tempat tidur pasien yang tidak terpasang handrell pada pasien rawat inap. Perawat telah memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien agar selalu memasang handrell tetapi seringkali keluarga pasien tidak memasang kembali handrell ketika pasien telah dari kamar mandi. Temuan pada unit IGD yaitu kurangnya kepedualian petugas dalam upaya pencegahan risiko jatuh, hal ini diketahahui dari ditemukannya pasien IGD dengan tempat tidur yang tidak terpasang handrel dan tanda risiko jatuh yang tidak diberikan pada tempat tidur pasien. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi petugas yang masih rendah dalam menjalankan prosedur keselamatan pasien secara konsisten.



ACTION/RTL	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PELAKSANA	WAKTU
- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	- Meningkatkan capaian indikator kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh	- Capaian indikator kepatuhan terhadap upaya pencegahan resiko jatuh bisa mencapai 100%.	- Melakukan supervisi berjenjang mulai dari PJ shift, kepala ruangan, kepala bidang keperawatan dan tim mutu guna memastikan perawat ruangan telah melakukan KIE kepada pasien dan keluarga tentang upaya pencegahan resiko jatuh harus lebih ditekankan dan disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa edukasi telah dilakukan. - Memberikan teguran langsung kepada petugas yang tidak melakukan upaya pencegahan resiko jatuh - Meningkatkan pengetahuan perawat mengenai SPO pencegahan resiko jatuh dengan cara melakukan sosialisasi kembali dan pengajuan diklat sasaran keselamatan pasien.	Perawat instalasi rawat inap	- Satu Bulan

12. Kecepatan waktu tanggap complain

Gambar 12. Grafik Capaian Indikator Kecepatan Waktu Tanggap Complain



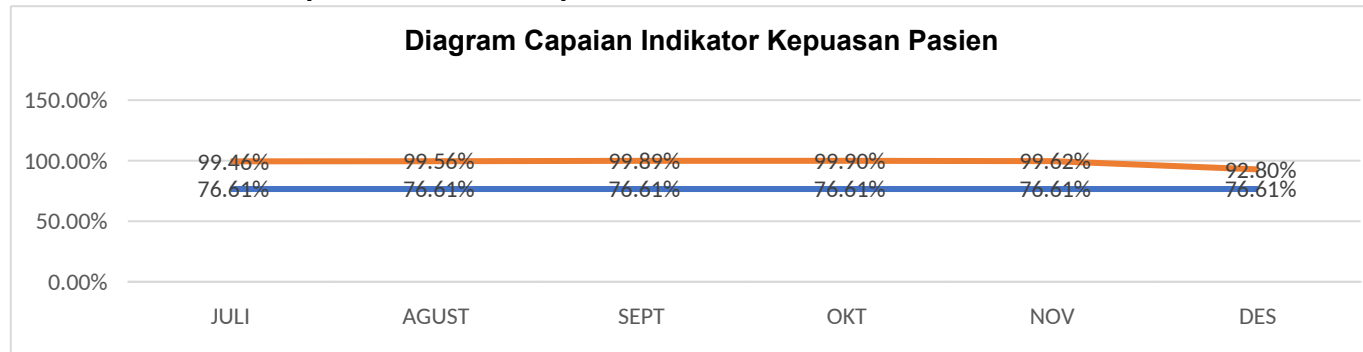
Dari grafik indikator waktu tanggap kompalian bulan Juli hingga Desember tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 80% dengan rata-rata 99,99%, hal ini berkat kerjasama yang baik antara PIPP dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk segera menanggapi dan melakukan tindak lanjut terkait complain yang diterima. Upaya lain yang telah dilakukan adalah mekanisme pelaporan yang mudah bisa langsung melalui PIPP, bisa



melalui tlp, WA dan formulir online. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di bulan berikutnya. Adanya staf yang terlatih khusus dalam manajemen komplain dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan supaya indikator kecepatan waktu tanggap complain dapat tercapai.

13. Kepuasan Pasien

Gambar 13. Grafik Capaian Indikator Kepuasan Pasien



Dari grafik indikator kepuasan pasien bulan Juli hingga Desember tahun 2025 diketahui capaian telah mencapai standart lebih dari 76,61% dengan rata-rata 98,97%, meskipun belum mencapai nilai sempurna 100% tetapi capaian ini telah melebihi standart. Hal ini karena kerjasama yang baik antara seluruh karyawan Rumah Sakit Prima Husada Malang dan juga manajemen Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah bersinergi untuk berfokus pada kualitas pelayanan secara keseluruhan. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan di tahun berikutnya.

DATA SURVEILANS HAI's
RS PRIMA HUSADA MALANG

❖ Tabel Data HAI's RS Prima Husada Malang Periode Januari – Juni 2025

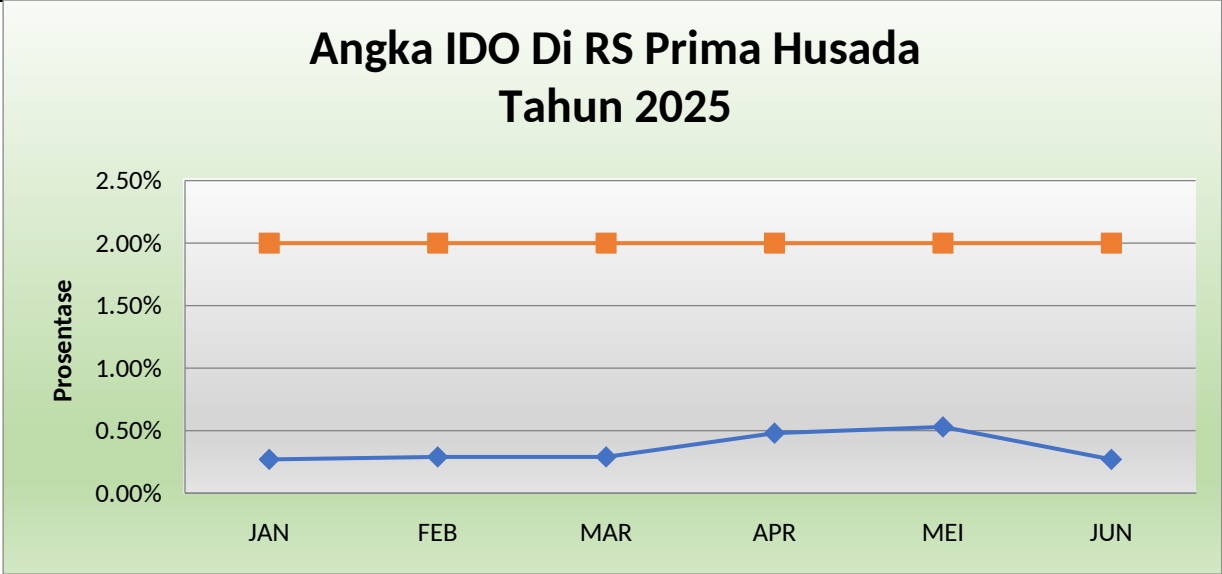
Jenis HAI's	Standart Nasional	Rate Infeksi % atau ‰					
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,27%	0,29%	0,29%	0,48%	0,53%	0,27%
IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,21%	0,23%	0,23%	0,1%	0,51%	0,61%
Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

❖ Tabel Data HAI's RS Prima Husada Malang Periode Juli – Desember 2025

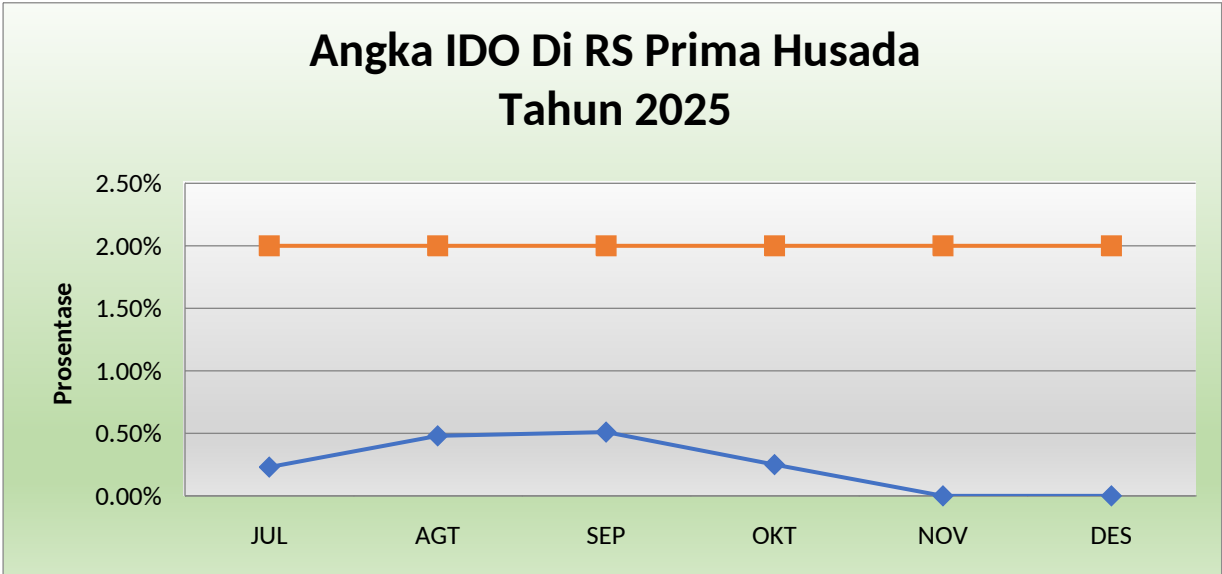
Jenis HAI's	Standart Nasional	Rate Infeksi % atau ‰					
		JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
IDO (Infeksi Daerah Operasi)	≤ 2 %	0,23%	0,49%	0,51%	0,25%	0%	0%
IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)	≤3,5‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	≤ 5,8 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
ISK (Infeksi Saluran Kencing)	≤ 4,7 ‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰	0‰
Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	≤ 5 %	0,73%	0,78%	0,42%	0,77%	0,2%	0,1%
Decubitus	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

❖ Grafik Data HAI's RS Prima Husada Malang Periode Januari – Juni 2025

a. IDO (Infeksi Daerah Operasi)



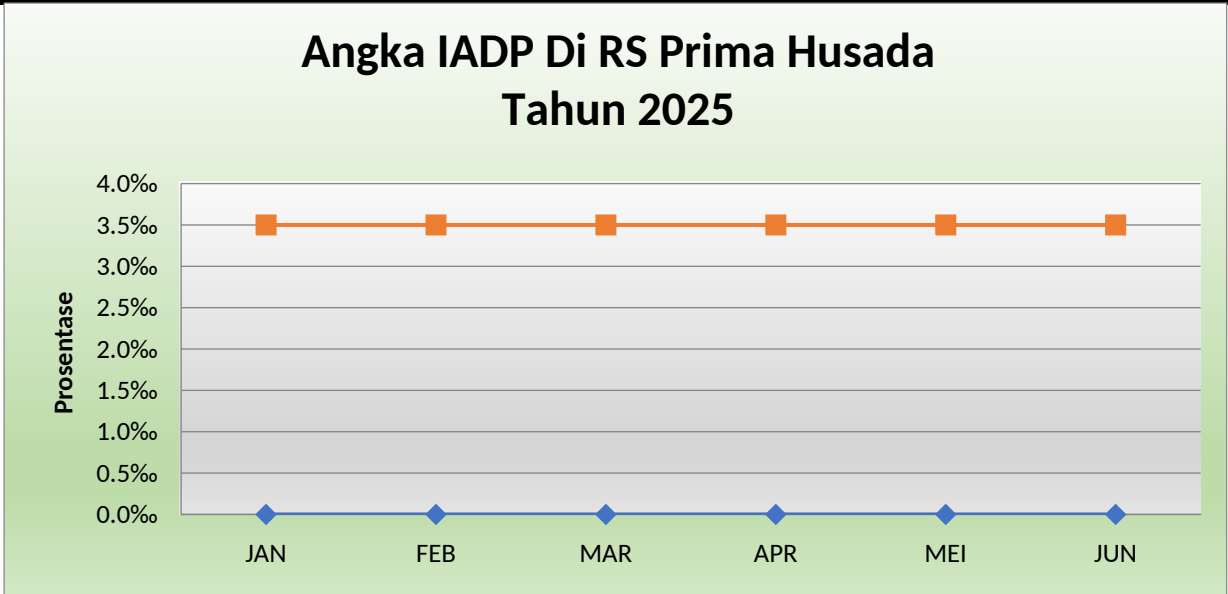
Gambar 1.1 Grafik Angka IDO RS Prima Husada Malang Periode Januari – Juni 2025



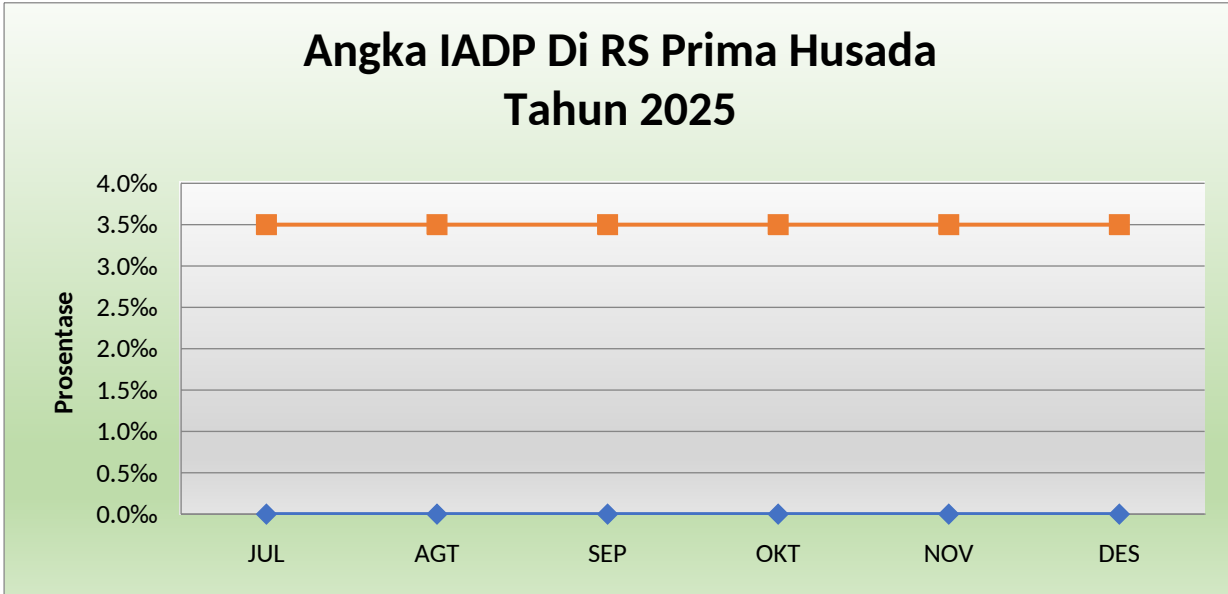
Gambar 1.2 Grafik Angka IDO RS Prima Husada Malang Periode Juli - Desember 2025

Definisi Operasional	Infeksi Daerah Operasi adalah Infeksi yang terjadi pada daerah insisi daerah operasi dalam waktu 30 hari tanpa implan dan satu tahun dengan implan pasca bedah atau 90 hari pasca bedah dengan prosedur pemasangan implan. Kriteria Infeksi: 1) Pus keluar dari luka operasi atau drain yang dipasang diatas fascia; 2) Biakan positif dari cairan yang keluar dari luka atau jaringan yang diambil secara aseptik; 3) Sengaja dibuka oleh dokter karena terdapat tanda peradangan, kecuali hasil biakan negative (paling sedikit terdapat satu dari tanda-tanda infeksi berikut ini : nyeri, bengkak lokal, 4) Dokter yang menangani menyatakan terjadi infeksi.
Numerator (N)	Jumlah kasus Infeksi Daerah Operasi (IDO)
Denominator (D)	Jumlah kasus operasi
Formula pengukuran	$(\text{Jumlah kasus IDO dibagi Jumlah kasus operasi}) \times 100 \%$

b. IADP (Infeksi Aliran Darah Primer)



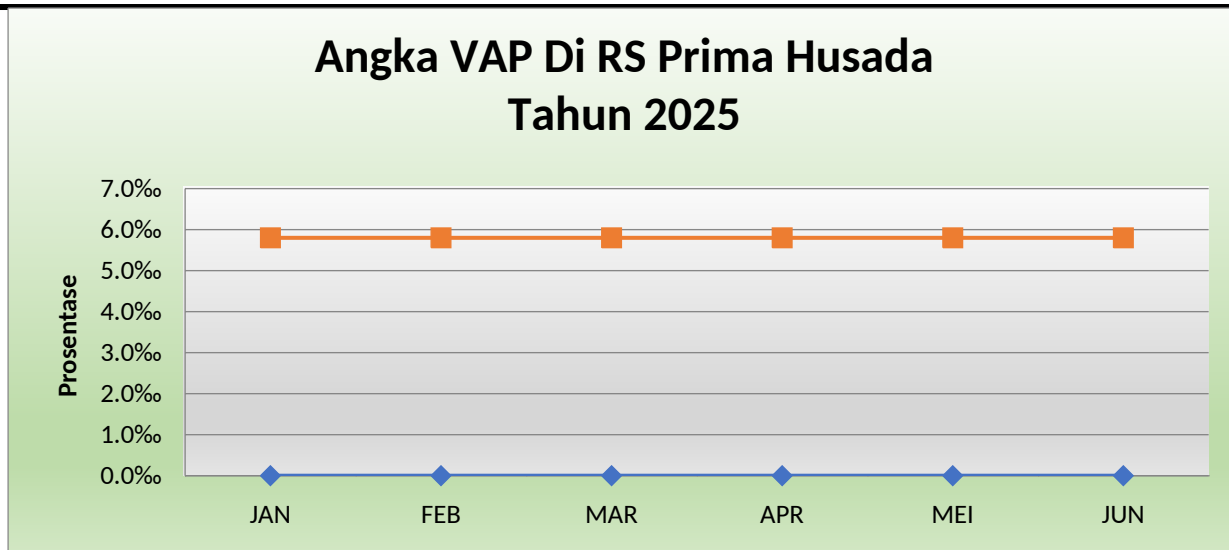
Gambar 1.3 Grafik Angka IADP RS Prima Husada Malang Periode Januari – Juni 2025



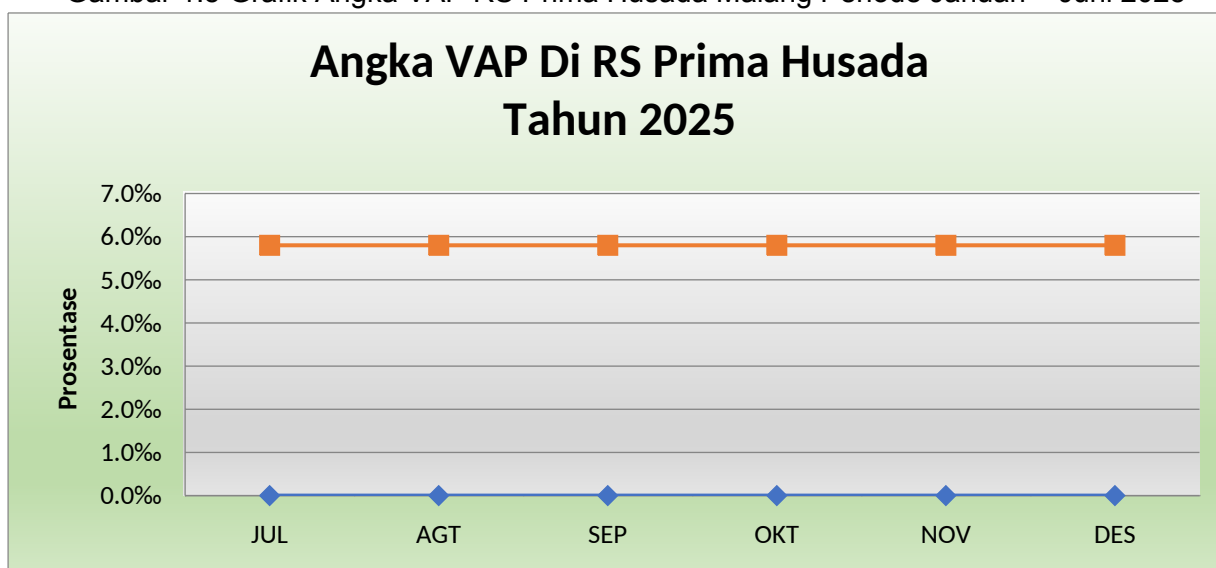
Gambar 1.4 Grafik Angka IADP RS Prima Husada Malang Periode Juli - Desember 2025

Definisi Operasional	Infeksi aliran darah primer terkait pemasangan kateter intravaskuler, adalah infeksi aliran darah terkait pemasangan central venous catheter (CVC).
Numerator (N)	Jumlah kasus IADP
Denominator (D)	Jumlah hari terpasang CVC
Formula pengukuran	Jumlah kasus IADP dibagi Jumlah hari terpasang CVC x 1000

c. VAP (Ventilation Associated Pneumonia)



Gambar 1.5 Grafik Angka VAP RS Prima Husada Malang Periode Januari – Juni 2025



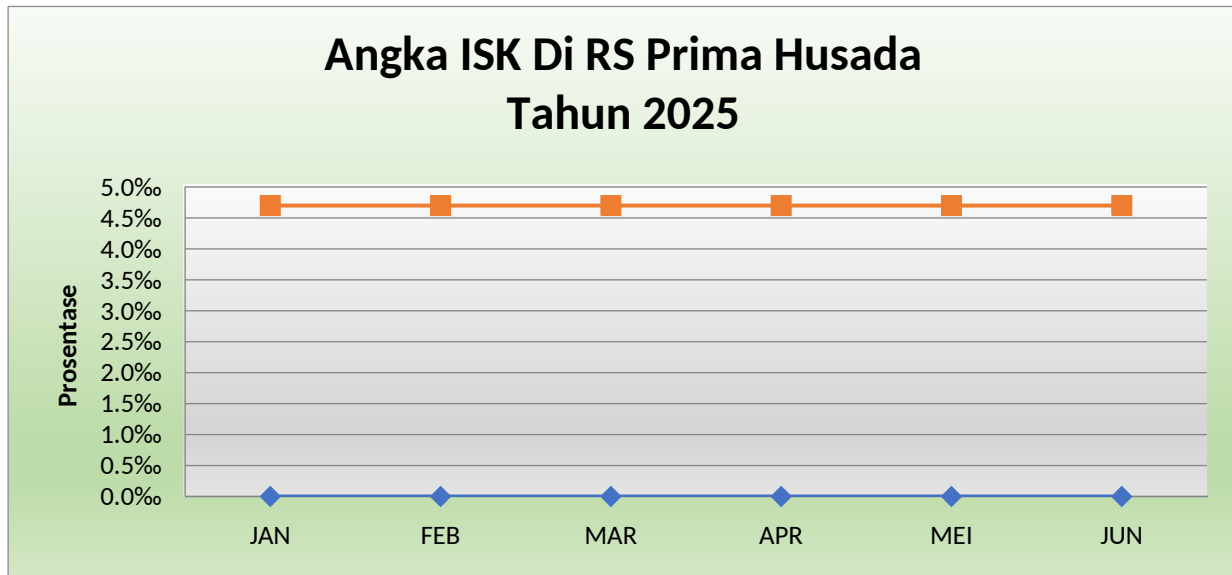
Gambar 1.6 Grafik Angka VAP RS Prima Husada Malang Periode Juli – Desember 2025



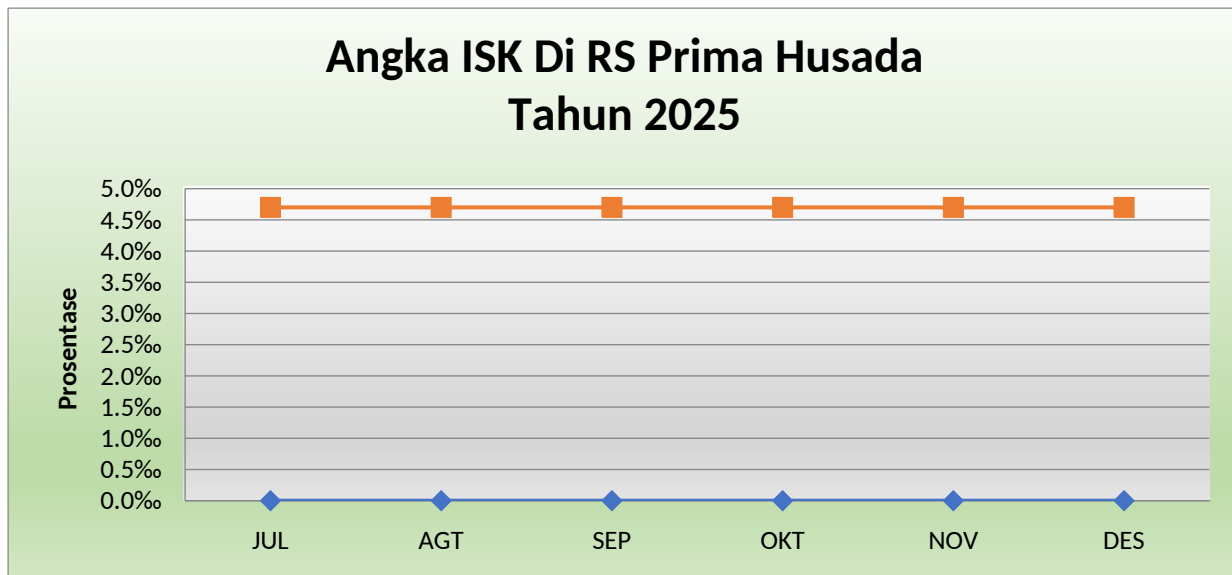
Definisi Operasional	Ventilator-Associated Pneumonia (VAP) adalah infeksi saluran napas bawah yang mengenai parenkim paru setelah pemakaian ventilasi mekanik > 48 jam, dan sebelumnya tidak ditemukan tanda-tanda infeksi saluran napas. Kriteria : Ditemukan minimal dari tanda dan gejala klinis : - Demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) tanpa ditemui penyebab lainnya. - Leukopenia ($< 4.000 \text{ WBC/mm}^3$) atau Leukositosis ($\geq 12.000 \text{ SDP/mm}^3$). - Untuk penderita berumur ≥ 70 tahun, adanya perubahan status mental yang tidak ditemui penyebab lainnya. Minimal disertai 2 dari tanda berikut: - Timbulnya onset baru sputum purulen atau perubahan sifat sputum. - Munculnya tanda atau terjadinya batuk yang memburuk atau dyspnea (sesak napas) atau tachypnea. - Ronki basah atau suara napas bronchial. - Memburuknya pertukaran gas, misalnya desaturasi O_2 ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 240$), peningkatan kebutuhan oksigen, atau perlunya peningkatan ventilator. Dasar diagnosis : Adanya bukti secara radiologis adalah jika ditemukan > 2 foto serial : Infiltrat baru atau progresif yang menetap; Konsolidasi; Kavitasi; Pneumatoceles pada bayi berumur < 1 tahun
Numerator (N)	Jumlah kasus infeksi Ventilator Associated Pneumonia (VAP)
Denominator (D)	Jumlah lama hari pemakaian atau terpasang Ventilator
Formula pengukuran	<u>(Jumlah kasus infeksi VAP dibagi Jumlah hari pemakaian atau terpasang Ventilator) x 1000</u>



d. ISK (Infeksi Saluran Kencing)



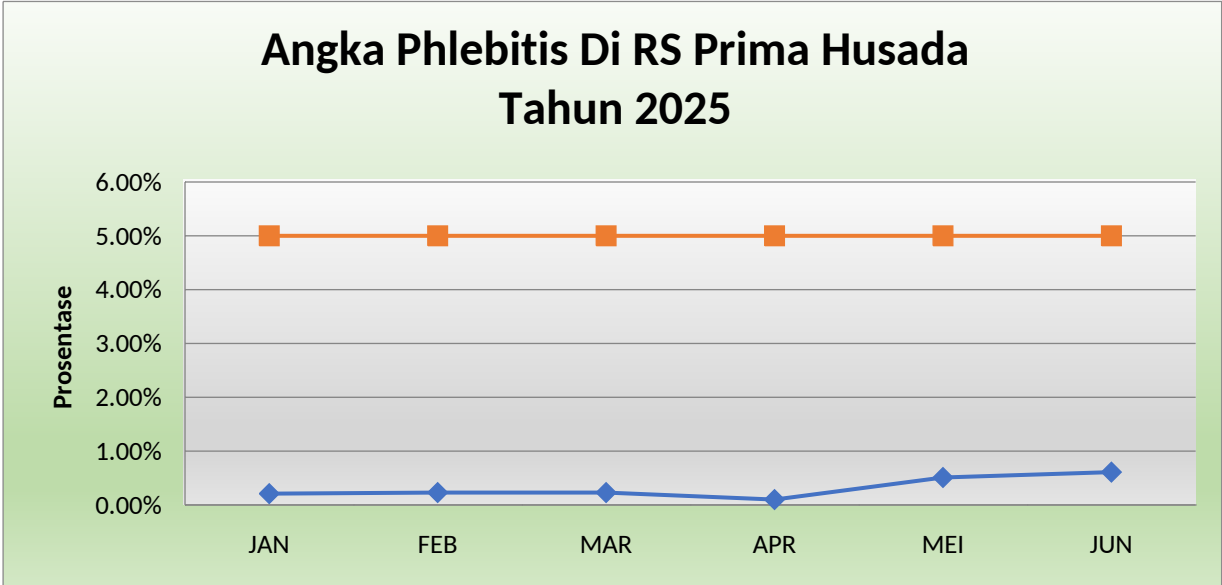
Gambar 1.7 Grafik Angka ISK RS Prima Husada Malang Periode Januari – Juni 2025



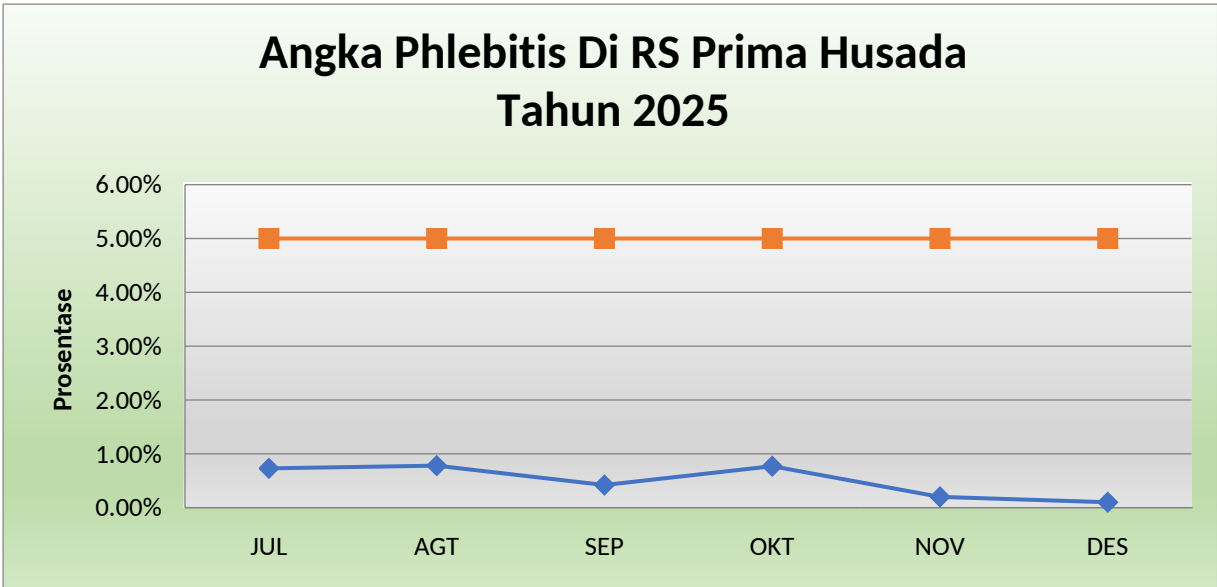
Gambar 1.8 Grafik Angka ISK RS Prima Husada Malang Periode Juli – Desember 2025

Definisi Operasional	Infeksi Saluran Kencing (ISK) adalah Infeksi yang terjadi sebagai akibat dari pemasangan kateter > 48 jam Kriteria : Gejala dan Tanda : a. Umum : demam, urgensi, frekuensi, disuria, nyeri suprapubik Usia < 1 tahun : demam, hipotermi, apneu, bradikardi, letargia, muntah-muntah. b. Nitrit dan/atau leukosit esterase positif dengan carik celup (dipstick). c. Pyuria > 10 leukosit/LPB sedimen urin atau >10 leukosit/mL atau > 3 leukosit/LPB dari urine tanpa dilakukan sentrifus. d. Terdapat koloni mikroorganisme pada hasil pemeriksaan urine kultur. e. Diagnosis dokter yang merawat menyatakan adanya ISK. f. Terapi dokter sesuai ISK
Numerator (N)	Jumlah kasus Infeksi Saluran Kemih (ISK)
Denominator (D)	Jumlah lama hari pemakaian kateter urin menetap
Formula pengukuran	$\frac{\text{Jumlah kasus ISK}}{\text{Jumlah lama hari pemakaian kateter urin menetap}} \times 1000$

e. Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)



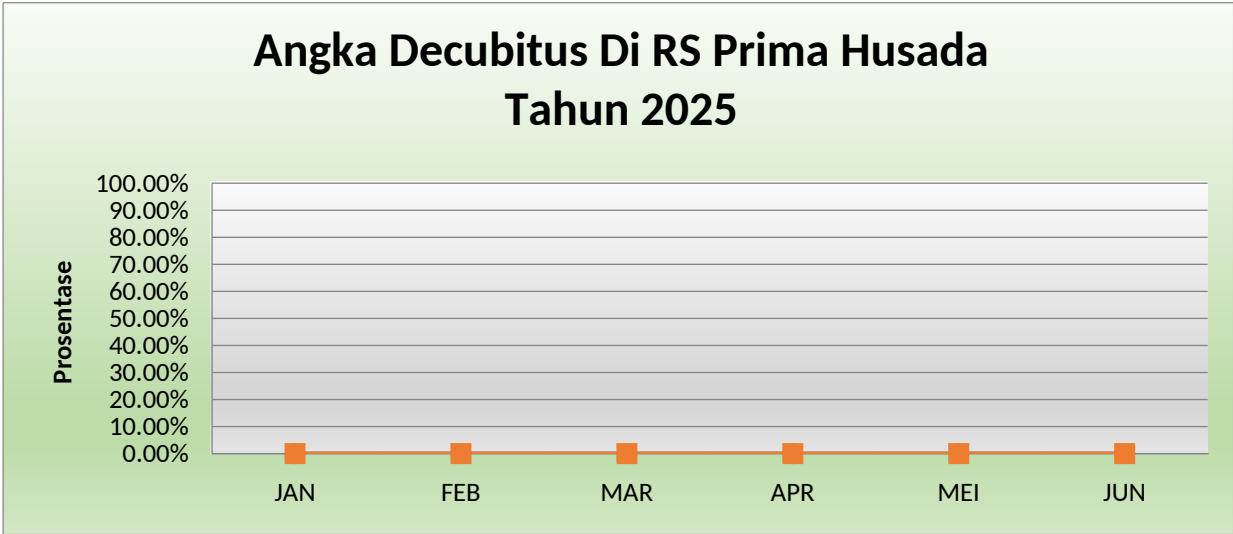
Gambar 1.9 Grafik Angka Phlebitis RS Prima Husada Malang Periode Januari – Juni 2025



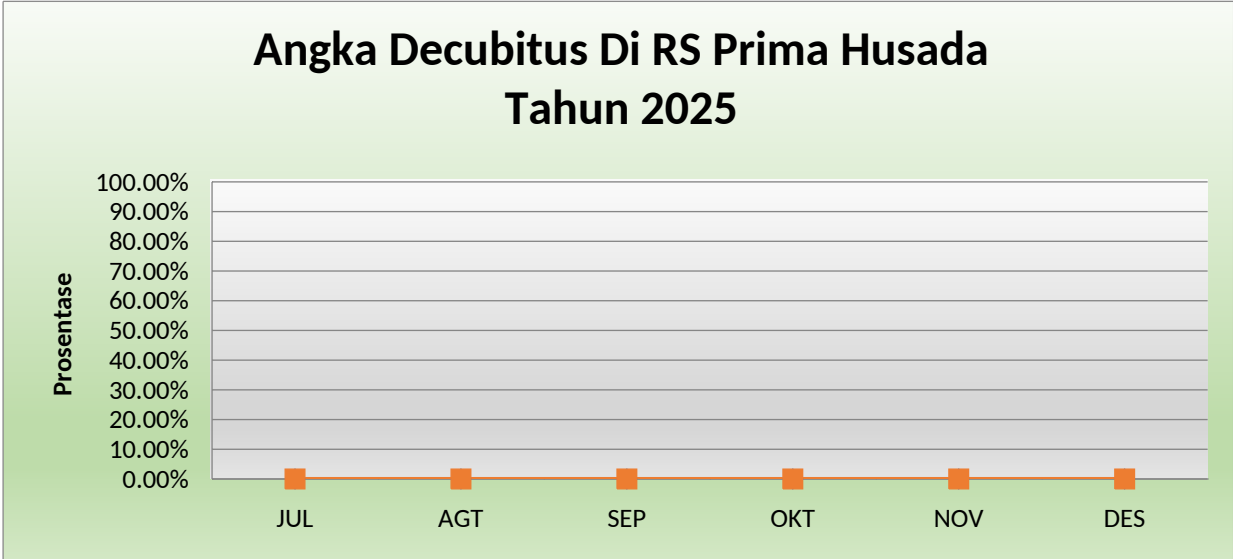
Gambar 1.10 Grafik Angka Phlebitis RS Prima Husada Malang Periode Juli – Desember 2025

Definisi Operasional	Phlebitis merupakan inflamasi pada vena, yang ditandai dengan adanya daerah yang merah, nyeri dan pembengkakan di daerah penusukan atau sepanjang vena (Brunner dan Sudarth, 2002). Angka phlebitis pasca pemasangan kateter vena perifer yang timbul <72 jam pemasangan.
Numerator (N)	Jumlah kasus Phlebitis
Denominator (D)	Seluruh pasien yang terpasang kateter intravena
Formula pengukuran	<u>(Jumlah kasus phlebitis dibagi Seluruh pasien yang terpasang kateter intravena) x 100%</u>

f. Decubitus



Gambar 1.11 Grafik Angka Dekubitus RS Prima Husada Malang Periode Januari – Juni 2025



Gambar 1.12 Grafik Angka Dekubitus RS Prima Husada Malang Periode Juli – Desember 2025

Definisi Operasional	Pasien yang menderita decubitus akibat tirah baring di rumah sakit.
Numerator (N)	Jumlah pasien decubitus
Denominator (D)	Jumlah pasien tirah baring
Formula pengukuran	$\frac{\text{Jumlah pasien decubitus}}{\text{Jumlah pasien tirah baring}} \times 100$

Mengetahui,
Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes